



INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 16:01

Centro de atención: Z01 - Zaragoza

Paciente: CC 1043639863 - LINA MARCELA DE LEON FUENTES

Fecha de Nacimiento: 07/09/2004

Religión:

Régimen: 2 - Subsidiado

Dirección: BARRIO ZARAGOCILLA CALLE 29 #50 25

Teléfono: 3205697845

Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO

OCUPACION

Grupo Poblacional:

Acompañante: BERTA FUENTES

Teléfono Acomp.:

Dirección Acomp.:

Responsable:

Teléfono Resp.:

Dirección Resp.:

Médico Tratante: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Fecha de Atención: 25/09/2024 11:59

Admisión: AD1005643

Edad: 20 año(s), 0 mes(es) 18 día(s)

Creencia:

Nivel: 1

Lugar: Cartagena Bolívar

Raza:

Parentesco Acomp.:

Parentesco Resp.: MAMA

Especialidad: MEDICINA INTERNA

Impreso por: AMRANDA

Sexo: F

Estado Civil: Soltero

Carnet:

Etnia:

Tipo Vinculación:

EPICRISIS

DATOS DE LA CONSULTA

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias

Fecha de Ingreso: 18/09/2024 16:56

Cama: CM948

Motivo de la Consulta:

"ESTOY ESCUPIENDO SANGRE DESDE HACE MEDIA HORA"

ANTECEDENTES:

* 1-> NIEGA

* 2-> NIEGA

* 5-> NIEGA

* 3-> NIEGA

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE FEMENINA DE 20 AÑOS DE EDAD SIN ANTECEDENTES PATOLÓGICOS REFERIDOS QUIEN ACUDE A SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLÍNICO DE APROXIMADAMENTE 10 DÍAS DE EVOLUCIÓN CARACTERIZADO POR SENSACIÓN FEBRIL ASOCIADO A TOS SECA, RINORRREA HIALINA. DESDE HACE 4 DÍAS PRESENTANDO EPISODIOS DE HEMOPTISIS. CONSULTA EL DÍA LUNES A URGENCIAS HUC DONDE SE LE REALIZA PARACLÍNICOS EVIDENCIANDO HEMOGRAMA SIN EVIDENCIA DE RESPUESTA CELULAR INFECCIOSA MAS RADIOGRAFIA DE TORAX CON EVIDENCIA DE CONSOLIDACIÓN PULMONAR DERECHA VALORADA EN CONJUNTO DR YEPEZ DADA DE ALTA CON MANEJO ANTIBIOTICO AMBULATORIO EN CONTEXTO DE NAC. RECONSULTA EL DÍA DE HOY POR PERSISTENCIA DE HEMOPTISIS MOTIVO POR EL CUAL COMENTO CASO A INTERNISTA EN TURNO DR SARMIENTO QUIEN CONSIDERA DE ACUERDO A RADIOGRAFIA QUE PACIENTE PODRIA ESTAR CURSANDO CON TBC. MOTIVO POR EL CUAL ORDENO PARACLÍNICOS DE EXTENSION Y TOMOGRAFIA DE TORAX PARA POSTERIOR VALORACION POR ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA. SE INFORMA CONDUCTA MEDICA A SEGUIR. REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Paciente femenina en la tercera década de la vida con TB pulmonar confirmada por baciloscopia y PCR positiva para M. tuberculosis, sensible a rifampicina + isoniazida. Con TAC de tórax que reporta ápices pulmonares derecho con pequeña cavitación, nódulos y opacidades en árbol en gemación. Se encuentra el día de hoy hemodinámicamente estable, con signos vitales en meta, saturando adecuadamente al oxígeno ambiente y tolerando vía oral además de mejoría clínica, no fiebre ni sudoración, con buen patrón respiratorio, con mejoría de tos. Cuenta con paraclínicos de control de función renal y hepática dentro de rangos normales. Actualmente pesando 40kg quién se encuentra recibiendo manejo para TBC con 3 tabletas diarias de terapia RIPE. Se decide dar egreso médico ante mejoría clínica y paraclínicos control dentro de normalidad, se dan recomendaciones de la importancia de buena adherencia al tratamiento, se indica ingreso a programa de TB eps, continuar aislamiento respiratorio. signos de alarma para reconsultar. Se explica a paciente y familiar quien refiere entender y aceptar.

Revisión Por Sistema:

PULMONAR

EXAMEN FISICO:

Apariencia a su llegada:

ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, COSNCIENTE, ALERTA, ORIENATDO EN LAS 3 ESFERAS.

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCÉFALO, ISOCÓRIAS, NORMORREACTIVAS, ESCLERAS ANICTERICAS, NARINAS PERMEABLES, MUCOSA ORAL HÚMEDA SIN LESIONES, CUELLO MÓVIL, SIMÉTRICO, SIN MASAS NI ADENOMEGLIAS, ARCOS DE MOVIMIENTO NORMALES. NO INGURGITACIÓN YUGULAR.

Tórax:

SIMÉTRICO, EXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN CAMPO PULMONAR DERECHO CON PRESENCIA DE CREPITOS. RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS DE BUEN TONO E INTENSIDAD. SIN SOPLOS

Abdomen:

ABDOMEN PERISTALSIS PRESENTE, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL NI PROFUNDA SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS. PUÑOPERCUSIÓN LUMBAR NEGATIVAS

Piel y faneras:

SIN LESIONES EVIDENTES

Genito-Urinario:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:59:12 p. m.

Admisión: AD1005643

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: LINA MARCELA DE LEON FUENTES

EPICRISIS

NO EXPLORADO

Extremidades:

SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMA, PULSOS DISTALES PRESENTES. LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS

Sistema nervioso central:

SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO APARENTE, PARES CRANEALES SIN ALTERACIONES, AUSENCIA DE SIGNOS MENINGEOS FUERZA MUSCULAR 5/5 EN TODAS LAS EXTREMIIDADES. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE FEMENINA DE 20 AÑOS DE EDAD SIN ANTECEDENTES PATOLÓGICOS REFERIDOS QUIEN ACUDE A SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLÍNICO DE APROXIMADAMENTE 10 DÍAS DE EVOLUCIÓN CARACTERIZADO POR SENSACIÓN FEBRIL ASOCIADO A TOS SECA, RINORRHEA HIALINA. DESDE HACE 4 DÍAS PRESENTANDO EPISODIOS DE HEMOPTISIS. CONSULTA EL DÍA LUNES A URGENCIAS HUC DONDE SE LE REALIZA PARACLÍNICOS EVIDENCIANDO HEMOGRAMA SIN EVIDENCIA DE RESPUESTA CELULAR INFECCIOSA MAS RADIOGRAFIA DE TORAX CON EVIDENCIA DE CONSOLIDACIÓN PULMONAR DERECHA VALORADA EN CONJUNTO DR YEPEZ DADA DE ALTA CON MANEJO ANTIBIOTICO AMBULATORIO EN CONTEXTO DE NAC. RECONSULTA EL DÍA DE HOY POR PERSISTENCIA DE HEMOPTISIS MOTIVO POR EL CUAL COMENTO CASO A INTERNISTA EN TURNO DR SARMIENTO QUIEN CONSIDERA DE ACUERDO A RADIOGRAFIA QUE PACIENTE PODRIA ESTAR CURSANDO CON TBC. MOTIVO POR EL CUAL ORDENO PARACLÍNICOS DE EXTENSION Y TOMOGRAFIA DE TORAX PARA POSTERIOR VALORACION POR ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA. SE INFORMA CONDUCTA MEDICA A SEGUIR. REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:**Diagnóstico Principal:**

R042 : HEMOPTISIS

Diagnóstico Relacionado 1:

J158 : OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS

EVOLUCIONES:

Fecha: 19/09/2024: 10:28:43, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Neumonía adquirida en la comunidad CURB 65 1 punto PSI Clase Valto riesgo

1.1 Lóbulo pulmonar derecho

2. Hemoptisis en estudio

2.1 Tuberculosis pulmonar a descartar

Subjetivo:

Paciente refiere hemoptisis, pasar buena noche y buena conciliación del sueño

Objetivo:

PA 100/70 mmHg, FC 78 lpm, FR 19 rpm, T 36.7°C, SpO2 98% a aire ambiente

Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, buen estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios.

Piel normocrómica, sin lesiones.

Conjuntivas palidas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, hipoventilación global de predominio en hemitorax derecho, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos.

Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS:

18/09/24

VDRL No reactivo

VIH no reactivo

HB 12.5 HTO 35.6 VCM 79.3 ADE 11.5 LEU 8.35 NEU 68 LIN 19.7 PLT 375

BUN 15 CRE 0.48

CL 102 K 4 NA 136

PCR 6.1

Radiografía de torax Previa 16/09/2024

Silueta cardíaca de configuración habitual.

Tráquea centrada.

Acentuación de los hilios pulmonares, se asocia consolidación con broncograma aéreo del lóbulo superior derecho de probable etiología infecciosa.

Senos costofrénicos libres.

Las estructuras óseas visualizadas sin hallazgos a mencionar.

Análisis:

Paciente femenina en la tercera década de la vida sin antecedentes de importancia, quien se encuentra hospitalizada en contexto de neumonía adquirida en la comunidad y hemoptisis secundaria al mismo cuadro cursante. Actualmente paciente hemodinámicamente estable, tolerando vía oral y oxígeno ambiente, afebril, sin signos de sirs, signos de irritación peritoneal u otra sintomatología asociada. Cuenta con radiografía de tórax del ingreso anterior que reporta acentuación de los hilios pulmonares, asociado a consolidación con broncograma aéreo del lóbulo superior derecho de probable etiología infecciosa. Se recibe paracrónico del día de hoy consistente en VDRL negativo, Aun a la espera de reporte oficial de baciloscopia + cultivo para m. tuberculosis y tomografía de tórax. En ronda médica matutina se considera seguir bajo mismo esquema de antibióticoterapia previamente instaurado dado que aún nos encontramos dentro de las primeras 48 h posterior al inicio de antibiótico, en caso de agravamiento clínico por parte de la paciente se realizará cambio antibiótico. Quedamos atentos a evolución clínica. Se le explica conducta médica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 20/09/2024: 11:49:20, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PROBLEMA:

TBC pulmonar con confirmación bacteriológica.

1. Neumonía adquirida en la comunidad CURB 65 1 punto PSI Clase Valto riesgo

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:59:12 p. m.

Admisión: AD1005643

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: LINA MARCELA DE LEON FUENTES

EPICRISIS

1.1 Lóbulo pulmonar derecho

2. Hemoptisis en estudio

Subjetivo:

refiere que ha estado mejor, no fiebre o sudoración, persiste solo tos ocasional. niega disnea

Objetivo:

PA 117/68 mmHg, FC109 lpm, FR 20rpm, T36.2 °C, SpO2 97% a aire ambiente Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, buen estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Conjuntivas palidas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, hipoventilación global de predominio en hemitorax derecho, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS:

PENDIENTE CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS (AMARILLO)

18/09/24

VIH no reactivo

HB 12.5 HTO 35.6 VCM79.3 ADE 11.5 LEU 8.35 NEU 68 LIN 19.7 PLT 375

BUN 15 CRE 0.48

CL 102 K 4 NA 136

PCR 6.1

18/09/2024

BACILOSCOPIA#1: Positivo para BAAR (+)

16/09/2024

HEMOGRAMA:

Leucocitos: 6.64, neutrófilos: 5.59, Linfocitos: 0.71, Monocitos: 0.03, Eosinófilos: 0.30, Basófilos: 0.02, Eritrocitos: 4.42, Hemoglobina: 12.5, Hematocrito: 35.0, VCM 79.0, HCM: 28.2, Plaq: 335

BUN: 12, Creatinina: 0.49

TP: 11.8, TTP: 27.1

IMAGENES

Radiografía de torax Previa 16/09/2024

Silueta cardiaca de configuración habitual.

Tráquea centrada.

Acentuación de los hilios pulmonares, se asocia consolidación con broncograma aéreo del lóbulo superior derecho de probable etiología infecciosa.

Senos costofrénicos libres.

Las estructuras óseas visualizadas sin hallazgos a mencionar.

Análisis:

Paciente femenina en la tercera década de la vida con TB pulmonar confirmada por baciloscopia. Pendiente cultivo para m. tuberculosis y tomografía de tórax (reporte). Se encuentra el día de hoy manifestando mejoría clínica, no fiebre ni sudoración, solo persiste tos. A la espera de inicio de medicación antifúngica solicitada el día de hoy. Quedamos atentos a evolución clínica. Se le explica conducta médica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 21/09/2024: 09:51:28, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

TBC pulmonar con confirmación bacteriológica.

1. Neumonía adquirida en la comunidad CURB 65 1 punto PSI Clase V alto riesgo

1.1 Lóbulo pulmonar derecho

Subjetivo:

refiere que ha estado mejor, no fiebre, no disnea o hemoptisis, persiste con tos e hiporexia, ayer inicio de RIPE con buena tolerancia

Objetivo:

PA 101/77mmHg, FC109 lpm, FR 20rpm, T36.2 °C, SpO2 97% a aire ambiente Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, buen estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Conjuntivas palidas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, hipoventilación global de predominio en hemitorax derecho, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS:

PENDIENTE CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS (AMARILLO)

18/09/24

VIH no reactivo

HB 12.5 HTO 35.6 VCM79.3 ADE 11.5 LEU 8.35 NEU 68 LIN 19.7 PLT 375

BUN 15 CRE 0.48

CL 102 K 4 NA 136

PCR 6.1

18/09/2024

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:59:12 p. m.

Admisión: AD1005643

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: LINA MARCELA DE LEON FUENTES

EPICRISIS

BACILOSCOPIA#1: Positivo para BAAR (+)

16/09/2024

HEMOGRAMA:

Leucocitos: 6.64, neutrófilos: 5.59, Linfocitos: 0.71, Monocitos: 0.03, Eosinófilos: 0.30, Basófilos: 0.02, Eritrocitos: 4.42, Hemoglobina: 12.5, Hematocrito: 35.0, VCM: 79.0, HCM: 28.2, Plaq: 335

BUN: 12, Creatinina: 0.49

TP: 11.8, TTP: 27.1

IMAGENES

Radiografía de torax Previa 16/09/2024

Silueta cardiaca de configuración habitual.

Tráquea centrada.

Acentuación de los hilios pulmonares, se asocia consolidación con broncograma aéreo del lóbulo superior derecho de probable etiología infecciosa.

Senos costofrénicos libres.

Las estructuras óseas visualizadas sin hallazgos a mencionar.

Análisis:

Paciente femenina en la tercera década de la vida con TB pulmonar confirmada por baciloscopia. Pendiente cultivo para m. tuberculosis y tomografía de tórax (reporte). Se encuentra el día de hoy manifestando mejoría clínica, no fiebre ni sudoración, solo persiste tos. Ayer inicio de terapia RIPE. Quedamos atentos a evolución clínica. Se le explica conducta médica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 22/09/2024: 11:54:33, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

TBC pulmonar con confirmación bacteriológica.

1. Neumonía adquirida en la comunidad CURB 65 1 punto PSI Clase Alto riesgo

1.1 Lóbulo pulmonar derecho

Subjetivo:

SUBJETIVO: refiere que ha estado mejor, no fiebre o sudoración, persiste solo tos ocasional. niega disnea

Objetivo:

OBJETIVO:

PA mmHg, FC lpm, FR rpm, T °C, SpO2 % a aire ambiente. Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, buen estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Conjuntivas palidas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, hipoventilación global de predominio en hemitorax derecho, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléjico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS:

PENDIENTE CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS (AMARILLO)

18/09/24

VH no reactivo

HB 12.5 HTO 35.6 VCM 79.3 ADE 11.5 LEU 8.35 NEU 68 LIN 19.7 PLT 375

BUN 15 CRE 0.48

CL 102 K 4 NA 136

PCR 6.1

18/09/2024

BACILOSCOPIA#1: Positivo para BAAR (+)

16/09/2024

HEMOGRAMA:

Leucocitos: 6.64, neutrófilos: 5.59, Linfocitos: 0.71, Monocitos: 0.03, Eosinófilos: 0.30, Basófilos: 0.02, Eritrocitos: 4.42, Hemoglobina: 12.5, Hematocrito: 35.0, VCM: 79.0, HCM: 28.2, Plaq: 335

BUN: 12, Creatinina: 0.49

TP: 11.8, TTP: 27.1

IMAGENES

Radiografía de torax Previa 16/09/2024

Silueta cardiaca de configuración habitual.

Tráquea centrada.

Acentuación de los hilios pulmonares, se asocia consolidación con broncograma aéreo del lóbulo superior derecho de probable etiología infecciosa.

Senos costofrénicos libres.

Las estructuras óseas visualizadas sin hallazgos a mencionar.

Análisis:

Paciente femenina en la tercera década de la vida con TB pulmonar confirmada por baciloscopia. Pendiente cultivo para m. tuberculosis y tomografía de tórax (reporte). Se encuentra el día de hoy manifestando mejoría clínica, no fiebre ni sudoración, solo persiste tos. Continúa en estancia hospitalaria recibiendo manejo de terapia RIPE. Quedamos atentos a evolución clínica. Se le explica conducta médica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 23/09/2024: 07:57:01, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:59:12 p. m.

Admisión: AD1005643

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: LINA MARCELA DE LEON FUENTES

EPICRISIS

TBC pulmonar con confirmación bacteriológica.

1. Neumonía adquirida en la comunidad CURB 65 1 punto PSI Clase V alto riesgo

1.1 Lóbulo pulmonar derecho

Subjetivo:

SUBJETIVO: refiere que ha estado mejor, no fiebre o sudoración, persiste solo tos ocasional. niega disnea

Objetivo:

OBJETIVO:

PA 101/77mmHg, FC109 lpm, FR 20rpm, T36.2 °C, SpO2 97% a aire ambiente Luce en regular estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, buen estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Conjuntivas palidas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, hipoventilación global de predominio en hemitorax derecho, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS:

PENDIENTE CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS (AMARILLO)

21/09/24

BACILOSCOPIA#3: POSITIVO PARA BAAR

20/09/2024

BACILOSCOPIA#2: POSITIVO PARA BAAR

18/09/2024

BACILOSCOPIA#1: Positivo para BAAR (+)

18/09/2024

TOMOGRAMA DE TORAX SIMPLE

Indicación:

Técnica: Con Tomógrafo Multidetector se realizan cortes axiales desde el opérculo torácico hasta el abdomen superior en fase simple.

HALLAZGOS

En lo incluido de la base del cuello no se identifican hallazgos de interés patológico.

Vía aérea de calibre normal. No se observó lesión endoluminal o compresión extrínseca.

No observó masas ni adenopatías mediastinales.

Aorta torácica y vasos supraaórticos de calibre y curso normal.

Índice cardiotorácico normal. No hay líquido pericárdico.

En ápice pulmonar derecho se evidencia pequeña cavitación, nodulos y opacidades en árbol en gemación que podrían estar en relación con proceso infeccioso de probable origen granulomatoso

En el parénquima pulmonar izquierdo no se identifican zonas de consolidación neumónica, atelectasias, masas o cavitaciones.

No observó líquido pleural ni neumotórax

En las estructuras óseas se muestran con densidad normal. No se aprecian fracturas, tampoco lesiones líticas o blásticas.

En el abdomen superior visible no se identifican lesiones.

Análisis:

Paciente femenina en la tercera década de la vida con TB pulmonar confirmada por baciloscopia. Cuenta con tac de tórax que reporta ápices pulmonares derecho con pequeña cavitación, nodulos y opacidades en árbol en gemación. Pendiente cultivo para m. tuberculosis. Se encuentra el día de hoy hemodinámicamente estable, con signos vitales en meta, saturando adecuadamente al oxígeno ambiente y tolerando vía oral además de mejoría clínica, no fiebre ni sudoración, solo persiste tos. Paciente actualmente pesando 40kg quien debe recibir 3 tabletas diarias de rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol. No ha podido recibir terapia RIPE por dosis mal calculadas. A la espera de corrección para dar inicio. Quedamos atentos a evolución clínica. Se le explica conducta médica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 24/09/2024: 12:23:45, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

TBC pulmonar con confirmación bacteriológica.

1. Neumonía adquirida en la comunidad CURB 65 1 punto PSI Clase V alto riesgo

1.1 Lóbulo pulmonar derecho

Subjetivo:

SUBJETIVO: Refiere que ha pasado buena noche, afebril, sin disnea, con persistencia de la tos

Objetivo:

OBJETIVO:

PA: 99/61 mmHg, FC: 97 lpm, FR: 20 rpm, T 35.4°C, SpO2: 99 % a aire ambiente Luce en buen estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, buen estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Conjuntivas isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS:

18/09/2024

BACILOSCOPIA X3 POSITIVO PARA BAAR(+)

Mycobacterium Tuberculosis, DNA Detector

RESULTADO:

COMPLEJO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS: DETECTABLE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:59:12 p. m.

Admisión: AD1005643

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: LINA MARCELA DE LEON FUENTES

EPICRISIS

IDENTIFICACIÓN DE RESISTENCIAS:

RIFAMPICINA: SENSIBLE

ISONIAZIDA: SENSIBLE

21/09/24

BACILOSCOPIA#3: POSITIVO PARA BAAR

20/09/2024

BACILOSCOPIA#2: POSITIVO PARA BAAR

18/09/2024

BACILOSCOPIA#1: Positivo para BAAR (+)

18/09/2024

TOMOGRAMA DE TORAX SIMPLE

Indicación:

Técnica: Con Tomógrafo Multidetector se realizan cortes axiales desde el opérculo torácico hasta el abdomen superior en fase simple.

HALLAZGOS

En lo incluido de la base del cuello no se identifican hallazgos de interés patológico.

Vía aérea de calibre normal. No se observó lesión endoluminal o compresión extrínseca.

No observó masas ni adenopatías mediastinales.

Aorta torácica y vasos supraaórticos de calibre y curso normal.

Índice cardiotorácico normal. No hay líquido pericárdico.

En apice pulmonar derecho se evidencia pequeña cavitación, nódulos y opacidades en árbol en gemación que podrían estar en relación con proceso infeccioso de probable origen granulomatoso.

En el parénquima pulmonar izquierdo no se identifican zonas de consolidación neumónica, atelectasias, masas o cavitaciones.

No observó líquido pleural ni neumotórax.

En las estructuras óseas se muestran con densidad normal. No se aprecian fracturas, tampoco lesiones líticas o blásticas.

En el abdomen superior visible no se identifican lesiones.

Análisis:

Paciente femenina en la tercera década de la vida con TB pulmonar confirmada por baciloscopia y PCR positiva para M tuberculosis, sensible a rifampicina + isoniazida. Cuenta con tac de tórax que reporta ápices pulmonares derecho con pequeña cavitación, nódulos y opacidades en árbol en gemación. Se encuentra el día de hoy hemodinámicamente estable, con signos vitales en meta, saturando adecuadamente al oxígeno ambiente y tolerando vía oral además de mejoría clínica, no fiebre ni sudoración, solo persiste tos. Paciente actualmente pesando 40kg quien se encuentra recibiendo manejo para TBC con 3 tabletas diarias de rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol. El día de hoy se solicitan paraclínicos de control de función renal y hepática (SS: AST, ALT, BILIRRUBINAS, CR, BUN) a la espera de resultados. Quedamos atentos a evolución clínica. Se le explica conducta médica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 25/09/2024: 11:46:46, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

TBC pulmonar con confirmación bacteriológica.

1. Neumonía adquirida en la comunidad CURB 65 1 punto PSI Clase V alto riesgo

1.1 Lóbulo pulmonar derecho

Subjetivo:

SUBJETIVO: Refiere que ha pasado buena noche, afebril, sin disnea, con persistencia de la tos

Objetivo:

OBJETIVO:

PA: 111/66 mmHg, FC: 99 lpm, FR: 20 rpm, T 36.4°C, SpO2: 98% a aire ambiente

Luce en buen estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, buen estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios. Piel normocrómica, sin lesiones. Conjuntivas isocoria normoreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpandible, no tirajes, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nómima y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxica, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS:

24/09/2024

BILIRRUBINA

BT 0.51, BD 0.19, BI 0.32

TRANSAMINASA GLUT 28

TRANSAMINASA 23

BUN: 15, CREATININA 0.73

Análisis:

Paciente femenina en la tercera década de la vida con TB pulmonar confirmada por baciloscopia y PCR positiva para M tuberculosis, sensible a rifampicina + isoniazida. Con TAC de tórax que reporta ápices pulmonares derecho con pequeña cavitación, nódulos y opacidades en árbol en gemación. Se encuentra el día de hoy hemodinámicamente estable, con signos vitales en meta, saturando adecuadamente al oxígeno ambiente y tolerando vía oral además de mejoría clínica, no fiebre ni sudoración, con buen patrón respiratorio, con mejoría de tos. Cuenta con paraclínicos de control de función renal y hepática dentro de rangos normales. Actualmente pesando 40kg quien se encuentra recibiendo manejo para TBC con 3 tabletas diarias de terapia RIPE. Se decide dar egreso médico ante mejoría clínica y paraclínicos control dentro de normalidad, se dan recomendaciones de la importancia de buena adherencia al tratamiento, se indica ingreso a programa de TB eps, continuar aislamiento respiratorio. signos de alarma para reconsultar. Se explica a paciente y familiar quien refiere entender y aceptar.

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Medidas Generales Ordenadas:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:59:12 p. m.

Admisión: AD1005643

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: LINA MARCELA DE LEON FUENTES

EPICRISIS

Fecha: 18/09/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN UNIPERSONAL

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

CABECERA A 30°

DIETA CORRIENTE

TAPON VENOSO

AMPICILINA SULBACTAM 3 G CADA 6 HORAS :::FI: 18/09/24:::

ACETAMINOFEN TAB 500 GR VO CADA 8 HORAS :::SI FIEBRE:::

TROMBOPROFILAXIS MECÁNICA NO FARMACOLÓGICA

SS/ BACILOSCOPIA + CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS

P/ VDRL

P/ TOMOGRAFIA DE TORAX DE ALTA RESOLUCIÓN

REGISTRAR SIGNOS VITALES

AVISAR CAMBIOS

Fecha: 18/09/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN UNIPERSONAL

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

CABECERA A 30°

DIETA CORRIENTE

TAPON VENOSO

AMPICILINA SULBACTAM 3 MG CADA 6 HORAS :::FI: 18/09/24:::

ACETAMINOFEN TAB 500 GR VO CADA 8 HORAS :::SI FIEBRE:::

TROMBOPROFILAXIS MECÁNICA NO FARMACOLÓGICA

SS/ BACILOSCOPIA + CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS

P/ VDRL

P/ TOMOGRAFIA DE TORAX DE ALTA RESOLUCIÓN

REGISTRAR SIGNOS VITALES

AVISAR CAMBIOS

Fecha: 18/09/2024

Indicaciones:

PESO 39.5 KG

OBSERVACION

DIETA CORRIENTE

TAPON VENOSO

OMEPRAZOL AMP 40 MG IV

DIPIRONA AMP 2 GR IV

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 20 MIN X 1 HORA

SS HEMOGRAMA, PCR, IONOGRAMA, VIH, VDRL

SS TAC DE TORAX

REVALORAR

Fecha: 18/09/2024

Indicaciones:

SSN 0.9% 500CC PASAR A RAZON DE 40CC/HORA

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 20 MIN X 1 HORA :::SUSPENDER:::

Fecha: 19/09/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN UNIPERSONAL

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

CABECERA A 30°

DIETA CORRIENTE

TAPON VENOSO

AMPICILINA SULBACTAM 3 G IV CADA 6 HORAS :::FI: 18/09/24:::

ACETAMINOFEN TAB 1 GR VO CADA 8 HORAS :::SI FIEBRE:::

TROMBOPROFILAXIS MECÁNICA NO FARMACOLÓGICA

P/ BACILOSCOPIA + CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS

P/ TOMOGRAFIA DE TORAX DE ALTA RESOLUCIÓN

REGISTRAR SIGNOS VITALES

AVISAR CAMBIOS

Fecha: 19/09/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN UNIPERSONAL

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

CABECERA A 30°

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:59:12 p. m.

Admisión: AD1005643

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: LINA MARCELA DE LEON FUENTES

EPICRISIS

DIETA CORRIENTE
TAPON VENOSO
AMPICILINA SULBACTAM 3 G IV CADA 6 HORAS :::FI: 18/09/24::
ACETAMINOFEN TAB 500 GR VO CADA 8 HORAS :::SI FIEBRE::
TROMBOPROFILAXIS MECÁNICA NO FARMACOLÓGICA
SS/ BACILOSCOPIA + CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS
P/ VDRL
P/ TOMOGRAFIA DE TORAX DE ALTA RESOLUCIÓN
REGISTRAR SIGNOS VITALES
AVISAR CAMBIOS

Fecha: 19/09/2024

Indicaciones:

PLAN
HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN UNIPERSONAL
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
CABECERA A 30°
DIETA CORRIENTE
TAPON VENOSO
AMPICILINA SULBACTAM 3 G CADA 6 HORAS :::FI: 18/09/24::
ACETAMINOFEN TAB 500 GR VO CADA 8 HORAS :::SI FIEBRE::
TROMBOPROFILAXIS MECÁNICA NO FARMACOLÓGICA
P/ BACILOSCOPIA + CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS
P/ TOMOGRAFIA DE TORAX DE ALTA RESOLUCIÓN
REGISTRAR SIGNOS VITALES
AVISAR CAMBIOS

Fecha: 20/09/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN UNIPERSONAL
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
CABECERA A 30°
DIETA CORRIENTE
TAPON VENOSO

TERAPIA RIPE

RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TAB DAR 3 TABLETAS VO CADA 24 HRS DE
LUNES A SABADO POR 56 DOSIS

AMPICILINA SULBACTAM AMP 3 G IV CADA 6 HORAS :::FI: 18/09/24:::D2
ACETAMINOFEN TAB 500MG, DAR 1 GR VO CADA 8 HORAS :::SI FIEBRE:::

TROMBOPROFILAXIS MECÁNICA NO FARMACOLÓGICA

P/ BACILOSCOPIA + CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS
P/ REP TOMOGRAFIA DE TORAX DE ALTA RESOLUCIÓN

REGISTRAR SIGNOS VITALES
AVISAR CAMBIOS

Fecha: 21/09/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN UNIPERSONAL
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
CABECERA A 30°
DIETA CORRIENTE
TAPON VENOSO

TERAPIA RIPE

RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TAB DAR 3 TABLETAS VO CADA 24 HRS DE
LUNES A SABADO POR 56 DOSIS

AMPICILINA SULBACTAM AMP 3 G IV CADA 6 HORAS :::FI: 18/09/24:::D3
ACETAMINOFEN TAB 500MG, DAR 1 GR VO CADA 8 HORAS :::SI FIEBRE:::

TROMBOPROFILAXIS MECÁNICA NO FARMACOLÓGICA

P/ BACILOSCOPIA + CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS
P/ REP TOMOGRAFIA DE TORAX DE ALTA RESOLUCIÓN

REGISTRAR SIGNOS VITALES
AVISAR CAMBIOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:59:12 p. m.

Admisión: AD1005643

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: LINA MARCELA DE LEON FUENTES

EPICRISIS

Fecha: 21/09/2024

Indicaciones:

TERAPIA RIPE

RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TAB DAR 2 TABLETAS VO CADA 24 HRS DE LUNES A SABADO POR 56 DOSIS**MODIFICADO***

Fecha: 22/09/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN UNIPERSONAL

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

CABECERA A 30°

DIETA CORRIENTE

TAPON VENOSO

TERAPIA RIPE

RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TAB DAR 3 TABLETAS VO CADA 24 HRS DE LUNES A SABADO POR 56 DOSIS**MODIFICADO****

AMPICILINA SULBACTAM AMP 3 G IV CADA 6 HORAS :::FI: 18/09/24::D4

ACETAMINOFEN TAB 500MG, DAR 1 GR VO CADA 8 HORAS :::SI FIEBRE:::

TROMBOPROFILAXIS MECÁNICA NO FARMACOLÓGICA

P/ CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS

P/ REP TOMOGRAFIA DE TORAX DE ALTA RESOLUCIÓN

REGISTRAR SIGNOS VITALES

AVISAR CAMBIOS

Fecha: 23/09/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN UNIPERSONAL

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

CABECERA A 30°

DIETA CORRIENTE

TAPON VENOSO

TERAPIA RIPE

RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TAB DAR 3 TABLETAS VO CADA 24 HRS DE LUNES A SABADO POR 56 DOSIS::PENDIENTE INICIAR:::

AMPICILINA SULBACTAM AMP 3 G IV CADA 6 HORAS :::FI: 18/09/24::D5

ACETAMINOFEN TAB 500MG, DAR 1 GR VO CADA 8 HORAS :::SI FIEBRE:::

TROMBOPROFILAXIS MECÁNICA NO FARMACOLÓGICA

P/ CULTIVO PARA M. TUBERCULOSIS

REGISTRAR SIGNOS VITALES

AVISAR CAMBIOS

Fecha: 24/09/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HABITACIÓN UNIPERSONAL

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

CABECERA A 30°

DIETA CORRIENTE

TAPON VENOSO

AMPICILINA SULBACTAM AMP 3 G IV CADA 6 HORAS :::FI: 18/09/24::D6

TERAPIA RIPE

RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TAB DAR 3 TABLETAS VO CADA 24 HRS DE LUNES A SABADO POR 56 DOSIS:::

ACETAMINOFEN TAB 500MG, DAR 1 GR VO CADA 8 HORAS :::SI FIEBRE:::

TROMBOPROFILAXIS MECÁNICA NO FARMACOLÓGICA

REGISTRAR SIGNOS VITALES

AVISAR CAMBIOS

Fecha: 25/09/2024

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:59:12 p. m.

Admisión: AD1005643

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: LINA MARCELA DE LEON FUENTES

EPICRISIS

Indicaciones:

CONTINUAR AISLAMIENTO RESPIRATORIO HASTA RESULTADO DE PRIMERA PRUBA BK EXTREINSTITUCIONAL NEGATIVO

Fecha: 25/09/2024

Indicaciones:

FORMULA MEDICA

BROMURO DE IPRATROPIO INH 20MCG, REALIZAR 4 PUFF CADA 8 HORAS POR 15 DIAS # 1

ACETAMINOFEN TAB 500MG, DAR 1 GR VO CADA 8 HORAS POR 5 DIAS # 30

Fecha: 25/09/2024

Indicaciones:

INGRESO A PROGRAMA DE TUBERCULOSIS

Fecha: 25/09/2024

Indicaciones:

TERAPIA RIPE

RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TAB DAR 3 TABLETAS VO CADA 24 HRS DE LUNES A SABADO POR 56 DOSIS

Justificación de indicaciones Terapéuticas:**Complicaciones:**

LAS RELACIONADAS A SU PATOLOGIA DE BASE

Servicio de Egreso: 000023|Hospitalización 7mo Piso**Fecha de Egreso:** 25/09/2024 11:57**Motivo de Salida:** Alta**Estado a la Salida:** Vivo**DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:****Diagnóstico Principal:** A150 : TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUBERCULOSO EN ESPUTO, CON O SIN CULTIVO**Diagnóstico Relacionado 1:** R042 : HEMOPTISIS**PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR MEDICINA:****Tratamiento Farmacológico:**

LO DESCRITO EN ORDENES MEDICAS

Recomendaciones Adicionales:

CITA POR INFECTOLOGIA

INGRESO A PROGRAMA DE TUBERCULOSIS

CONTINUAR AISLAMIENTO RESPIRATORIO HASTA RESULTADO DE PRIMERA PRUBA BK EXTREINSTITUCIONAL NEGATIVO

Aplica Cuidados de Enfermería: No

YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ
MEDICINA INTERNA
CC.45548454 - RM.16138